



République Algérienne Démocratique Et Populaire

**Ministère De L' enseignement Supérieur Et De
La Recherche Scientifique**

Université Constantine 3



Faculté De Médecine

Département De Médecine

Cours de sémiologie :

Les troubles de l' hémostase

Dr ZINEB BOUACHIBA

Maitre-assistant en Médecine Interne- EHDM

Enseignement de 3ème année médecine.

Année universitaire 2025-2026

Sémiologie des troubles l' hémostase

I. Introduction et définitions

L'hémostase regroupe l'ensemble des mécanismes physiologiques qui concourent à la prévention et à l'arrêt des saignements (hémorragies) consécutifs à une brèche vasculaire. Cette fonction vitale implique une coordination complexe entre trois composants essentiels : la paroi vasculaire, les plaquettes sanguines et les facteurs de coagulation plasmatiques.

L'hémostase physiologique comprend trois temps successifs et complémentaires :

1. **L'hémostase primaire (vasculo-plaquettaire)** : formation rapide d'un clou plaquettaire au site de la lésion
2. **L'hémostase secondaire (coagulation)** : stabilisation du caillot par formation d'un réseau de fibrine
3. **La fibrinolyse** : dissolution contrôlée du caillot une fois la réparation tissulaire accomplie

Il convient de distinguer l'hémostase de la coagulation au sens strict : la coagulation ne regroupe que l'hémostase primaire et secondaire (conduisant à la formation du caillot), alors que l'hémostase inclut également la fibrinolyse qui permet la recanalisation vasculaire.

II. Physiologie de l'hémostase

II.1 Hémostase primaire (vasculo-plaquettaire)

C'est la première ligne de défense contre le saignement. Elle vise à former rapidement un "clou plaquettaire" hémostatique au site de la lésion vasculaire.

Phase vasculaire

À l'état normal, les plaquettes tapissent en film continu la surface de l'endothélium des petits vaisseaux, assurant l'étanchéité. La couche interne des vaisseaux est naturellement antithrombogène : elle exprime des molécules inhibitrices telles que le monoxyde d'azote (NO) et la prostacycline (PGI₂), qui inhibent l'activation et l'agrégation plaquettaire.

À l'occasion d'une brèche vasculaire, plusieurs phénomènes se succèdent :

- Vasoconstriction réflexe du vaisseau lésé, médiée par des substances vasoconstrictrices libérées par l'endothélium (endothéline, sérotonine), réduisant le flux sanguin au site de la blessure.
- Activation endothéliale : l'endothélium endommagé expose le collagène sous-jacent et libère le Facteur Tissulaire (FT ou TF), initiateur majeur de la coagulation.

Phase plaquettaire

La réponse plaquettaire se déroule en trois étapes successives :

- Adhésion : les plaquettes se lient au collagène exposé via le récepteur GPIb-IX-V et le facteur von Willebrand (vWF), protéine adhésive indispensable.
- Activation : les plaquettes changent de forme (de discoides à sphériques), libèrent leur contenu granulaire (ADP, sérotonine, thromboxane A₂, facteurs de coagulation) et expriment des récepteurs de surface, notamment le complexe GPIIb/IIIa.
- Agrégation : les plaquettes activées se lient entre elles via le fibrinogène qui se fixe sur les récepteurs GPIIb/IIIa, aboutissant à la formation d'un bouchon plaquettaire instable.

II.2 Hémostase secondaire (coagulation)

L'hémostase secondaire correspond à l'activation de la cascade de coagulation, une série de réactions enzymatiques en cascade aboutissant à la transformation du fibrinogène soluble en fibrine insoluble.

Voies de la coagulation

- Voie extrinsèque (rapide) : initiée par le Facteur Tissulaire (FT/TF) exposé au site de la lésion. Le FT se complexe avec le Facteur VII activé (VIIa), formant un complexe activateur puissant. Cette voie est dite "extrinsèque" car elle nécessite un composant extérieur au sang (le FT tissulaire).

- Voie intrinsèque (plus lente) : initiée par le contact du Facteur XII (Hageman) avec des surfaces étrangères ou le collagène exposé. Elle implique successivement les facteurs XII, XI, IX et VIII.
- Voie commune : les deux voies convergent vers l'activation du Facteur X en Xa, qui active la prothrombine (Facteur II) en thrombine (Facteur IIa). La thrombine transforme le fibrinogène en monomères de fibrine, puis active le Facteur XIII qui stabilise le réseau de fibrine par des liaisons covalentes. Le caillot de fibrine stable consolide alors le bouchon plaquettaire (thrombus rouge).

Rôle central de la thrombine

La thrombine est l'enzyme centrale de la coagulation. Outre sa fonction fibrinoformante, elle possède des propriétés procoagulantes majeures : activation des facteurs V et VIII (amplification de la cascade), activation plaquettaire, et stabilisation du caillot via le Facteur XIII.

II.3 Fibrinolyse

La fibrinolyse est le processus ultérieur de dissolution contrôlée du caillot de fibrine une fois la réparation vasculaire accomplie. Elle constitue un mécanisme de protection contre les risques thrombotiques.

La plasmine, enzyme effectrice de la fibrinolyse, est produite par le foie sous forme inactive : le plasminogène. Celui-ci possède une affinité pour la fibrine et est incorporé dans le caillot lors de sa formation, permettant ainsi sa dégradation ultérieure au niveau même du caillot.

L'activation du plasminogène en plasmine est catalysée par deux activateurs principaux :

- L'urokinase (u-PA) : issue de la pro-urokinase, son activation est facilitée par la kallikréine (enzyme intervenant en début de coagulation) et par la plasmine elle-même (amplification positive de la fibrinolyse).
- L'activateur tissulaire du plasminogène (t-PA) : sécrété par la paroi vasculaire endothéliale après un traumatisme, c'est l'activateur physiologique majeur.

La plasmine est une protéase à spécificité relativement large : elle attaque la fibrine, le fibrinogène et les protéines de coagulation (facteurs V et VIII). Les produits de dégradation de la fibrine (PDF ou FDP) sont libérés dans la circulation et éliminés par le rein.

La fibrinolyse est elle-même contrôlée par des inhibiteurs : l'antiplasmine α_2 inactive la plasmine, tandis que les inhibiteurs de l'activateur du plasminogène (PAI-1 et PAI-2) régulent

l'activation du plasminogène.

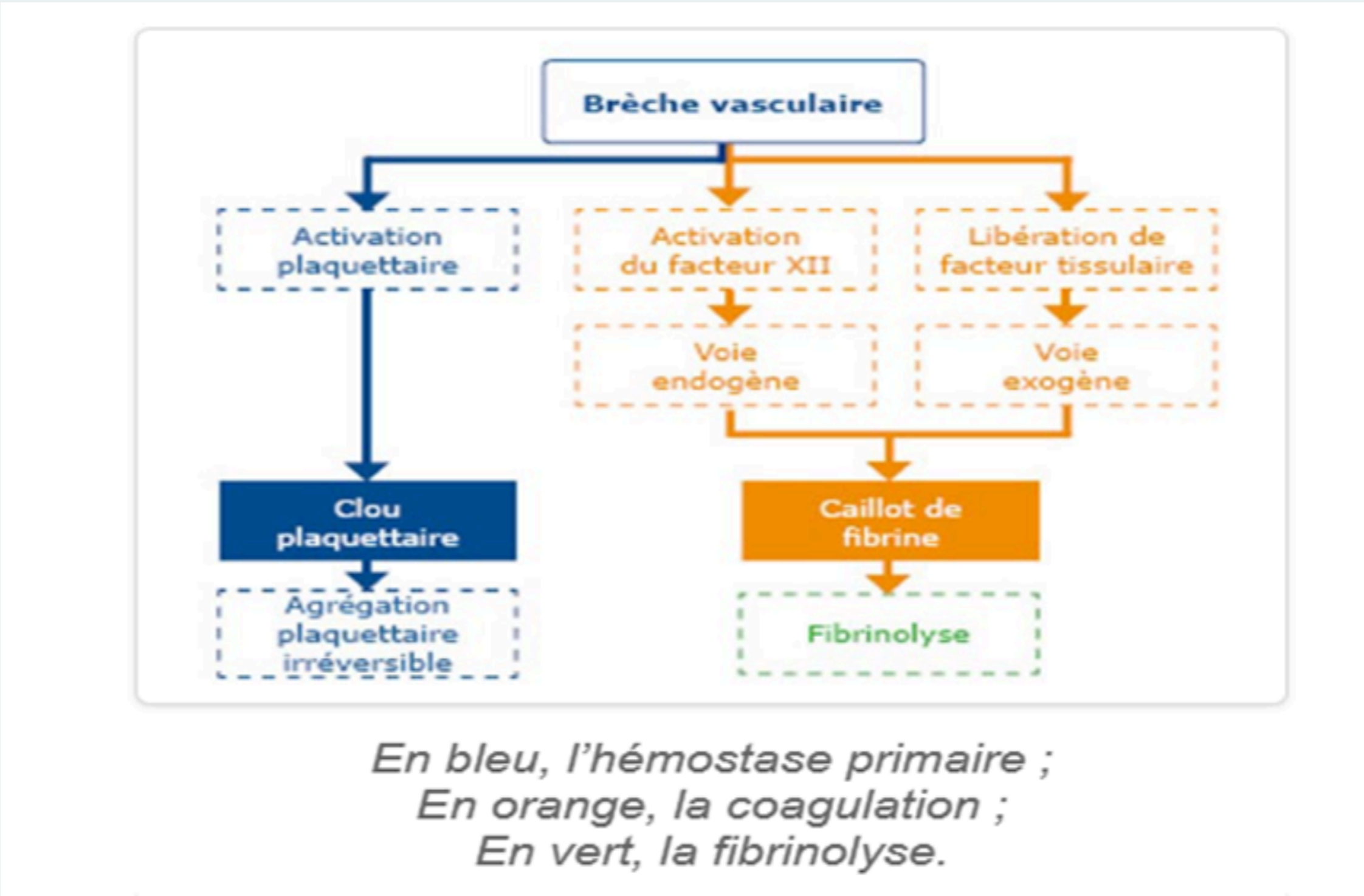
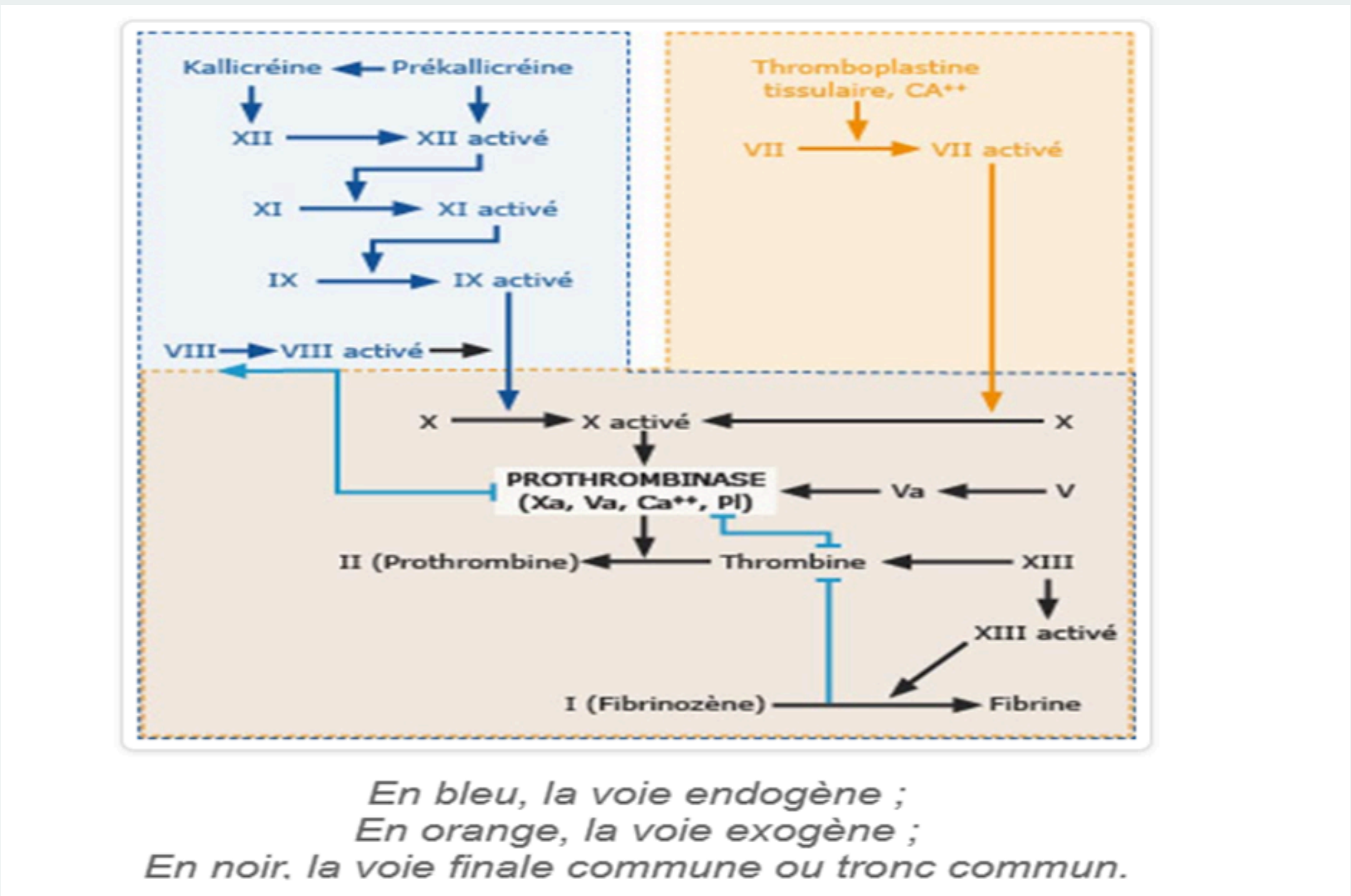


Schéma simplifié de la coagulation



III. Exploration biologique des troubles de l'hémostase

III.1 Exploration de l'hémostase primaire

L'hémostase primaire est explorée par des tests globaux et la numération plaquettaire.

Signe du lacet (tourniquet de Rumpel-Leede)

Le test est réalisé au lait du malade à l'aide du brassard du tensiomètre maintenu gonflé pendant 5 minutes à la pression moyenne (mi-chemin entre la pression systolique et diastolique). Après dégonflage, on observe la peau de l'avant-bras et on compte le nombre de pétéchies apparues.

Résultat normal : absence ou moins de 10 pétéchies. Le test est peu spécifique ; il est positif au cours des anomalies de la paroi vasculaire et des anomalies plaquettaires.

Temps de saignement (TS)

Le TS mesure le temps nécessaire à un vaisseau pour arrêter un saignement. Il explore l'ensemble de l'hémostase primaire (paroi vasculaire + plaquettes).

Deux techniques sont possibles :

- Technique de Duke (obsolète) : scarification du lobule de l'oreille, mesure sur papier buvard. Normale : 2-4 minutes. Cette technique est peu sensible et mal standardisée ; elle ne doit plus être utilisée.
- Technique d'Ivy (méthode de référence) : 3 incisions sur l'avant-bras sous pression faible (4 cm Hg) exercée par un tensiomètre. Résultats : pathologique si supérieur à 4-6 minutes (Ivy 3 points) ou 8-10 minutes (Ivy incision).

Numération plaquettaire

C'est un examen indispensable de l'étude de l'hémostase primaire. La numération plaquettaire normale se situe entre 150 et 450 G/L (150 000 à 450 000/mm³). Elle doit toujours être contrôlée par l'examen des plaquettes sur frottis sanguin.

Une numération anormale peut révéler : une thrombopénie ou thrombopathie (héréditaire ou acquise), une maladie de Willebrand, une afibrinogénémie, une anomalie des vaisseaux, ou une anémie sévère.

III.2 Exploration de la coagulation

Les tests les plus utilisés sont le Temps de Céphaline avec Activateur (TCA) et le Taux de Prothrombine (TP ou Temps de Quick, TQ).

Temps de Howell

C'est le temps de coagulation du plasma décalcifié, recalcifié in vitro. La normale est voisine de 1 minute 30 secondes. Il explore la thromboplastinoformation endogène, la thrombinoformation et la fibrinoformation. Cependant, il est peu sensible et peu reproductible ; son utilisation est devenue marginale.

TCA (Temps de Céphaline avec Activateur)

C'est le temps de coagulation d'un plasma citraté déplaquetté auquel on ajoute un activateur des facteurs de contact et de la céphaline (substitut du facteur 3 plaquettaire), puis du calcium après incubation à 37°C.

Le TCA normal varie de 30 à 40 secondes selon les réactifs et appareils. Le temps du malade est comparé au temps d'un témoin ; le ratio malade/témoin ne doit pas dépasser 1,2.

Le TCA explore la voie endogène de la coagulation : prékallikréine, kininogène de haut poids moléculaire, facteurs XII, XI, IX, VIII, ainsi que la voie finale commune (facteurs X, V, II, I).

TP / TQ (Taux de Prothrombine / Temps de Quick)

C'est le temps de coagulation du plasma décalcifié, recalcifié in vitro en présence de thromboplastine tissulaire. Il explore la voie exogène (facteur VII) et la voie finale commune (facteurs X, V, II, I).

Les résultats peuvent être exprimés de plusieurs façons :

- En secondes par rapport à un témoin : normale de 10 à 14 secondes selon la thromboplastine.
- En pourcentage d'activité (Taux de Prothrombine, TP) : normale de 70 à 100%.
- En INR (International Normalized Ratio) : $INR = [TQ \text{ malade} / TQ \text{ témoin}]ISI$. L'ISI (International Sensitivity Index) est défini pour chaque thromboplastine afin de standardiser les résultats entre laboratoires. L'INR est indispensable pour la surveillance des traitements par antivitamines K.

Temps de Thrombine (TT)

C'est le temps de coagulation du plasma décalcifié, recalcifié in vitro en présence de thrombine exogène. Il explore la fibrinoformation (transformation du fibrinogène en fibrine), mais pas la stabilisation par le facteur XIII.

Le TT est allongé en cas d'inhibiteurs de la fibrinoformation (héparine, produits de dégradation de la fibrine), d'hypofibrinogénémie ou de dysfibrinogénémie. La normale varie de 15 à 20 secondes.

Temps de Réptilase (TR)

Il s'agit d'un TT dans lequel la thrombine est remplacée par la réptilase. Cette enzyme est insensible à l'héparine, ce qui permet d'explorer la fibrinoformation chez les patients sous héparine. Un TR allongé avec TT normal suggère un effet de l'héparine.

Dosage des facteurs de coagulation

Le fibrinogène est dosé en grammes par litre (normale : 2 à 4 g/L). Les autres facteurs sont exprimés en pourcentage de la valeur normale. Le dosage individuel des facteurs permet de préciser le type de déficit en cas d'allongement isolé du TCA ou du TP.

Interprétation des allongements du TQ et du TCA

Tableau récapitulatif des anomalies selon les résultats des tests de coagulation :

TP	TCA	TT	Diagnostic
Allongé	Normal	Normal	Déficit en Facteur VII
Allongé	Allongé	Normal	Déficit voie commune (X, V, II)
Normal	Allongé	Normal	Déficit voie intrinsèque (VIII, IX, XI, XII)
Allongé	Allongé	Allongé	Déficit en fibrinogène / CIVD
Normal	Normal	Allongé	Héparine / dysfibrinogénémie

III.3 Exploration de la fibrinolyse

L'exploration de la fibrinolyse associe des tests globaux et des tests spécifiques.

Tests globaux

- Temps de lyse des euglobulines : la précipitation des euglobulines permet de séparer le fibrinogène, le plasminogène et ses activateurs des inhibiteurs des protéases. Le temps normal est supérieur à 3 heures. Un temps inférieur signe une "hyperfibrinolyse".

Tests indirects

- Dosage du fibrinogène : une baisse du fibrinogène permet de suspecter une hyperfibrinolyse ou une consommation.
- Temps de réptilase et/ou temps de thrombine : allongés en présence de produits de dégradation de la fibrine (PDF).
- Dosage des D-dimères : fragments spécifiques de dégradation de la fibrine, élevés en cas d'activation de la fibrinolyse secondaire à une formation de caillots. C'est le marqueur le plus spécifique de la fibrinolyse.
- Dosage des produits de dégradation de la fibrine et du fibrinogène (PDF/FDP) : élevés en cas d'activation de la fibrinolyse.
- Complexes solubles (monomères de fibrine associés à des PDF ou du fibrinogène) : permettent le diagnostic différentiel entre CIVD et fibrinolyse primaire.

Situations pathologiques

La CIVD (Coagulation Intravasculaire Disséminée) est la situation la plus caractéristique : pour diverses raisons pathologiques, la coagulation est activée de manière diffuse avec production de caillots dans tous les vaisseaux, entraînant une consommation des facteurs de coagulation et des plaquettes (risque hémorragique) et une "hyperfibrinolyse" secondaire.

La fibrinolyse primaire, plus rare, correspond à une activation pathologique de la fibrinogénolyse sans CIVD associée.

IV. Sémiologie clinique des syndromes hémorragiques

Quel que soit le syndrome hémorragique constaté, l'examen clinique initial est le même. Il vise à orienter soit vers une pathologie acquise de l'hémostase (conséquence d'une maladie associée), soit plus rarement vers une pathologie constitutionnelle. Il guide également l'exploration biologique.

IV.1 Interrogatoire

Antécédents

- Rechercher des antécédents personnels et familiaux de saignements, de thrombopénie, de maladies hématologiques, de troubles de la coagulation.

- Identifier les médicaments pris : anticoagulants, antiagrégants plaquettaires (aspirine, clopidogrel), AINS, et autres médicaments potentiellement hémorragiques.
- Déterminer les antécédents chirurgicaux et les complications hémorragiques éventuelles (extractions dentaires, interventions majeures, circoncision).

Mode de début des saignements

- Préciser si les saignements sont spontanés, post-traumatiques ou post-opératoires.
- Évaluer l'abondance (quantité, durée) et la localisation des saignements.
- Saisir la chronologie : hémorragies immédiates (suggèrent une anomalie de l'hémostase primaire) ou retardées (suggèrent une anomalie de la coagulation).

Symptômes associés

- Rechercher des signes cliniques associés : ecchymoses, purpura, pétéchies, épistaxis, gingivorragies, méléna, hématurie, hémarthroses.
- Évaluer la présence d'autres signes généraux : fièvre, douleurs, altération de l'état général, adénopathies, splénomégalie.

IV.2 Examen clinique

Inspection

- Signes de saignement cutanéomuqueux : pétéchies, purpura, ecchymoses, vibices, gingivorragies, épistaxis.
- Hémorragies profondes : hématomes sous-cutanés, hémarthroses (gonflement articulaire), hémorragies musculaires ou viscérales.
- Signes de choc hémorragique : pâleur, tachycardie, hypotension, marbrures, oligurie.

Palpation

- Rechercher des adénopathies, une splénomégalie ou une hépatomégalie (signes d'hématopathologie ou d'insuffisance hépatique).
- Palpation des articulations : recherche d'épanchement articulaire (hémarthrose), de chaleur locale, de douleur ou de limitation de la mobilité.

Signes de gravité à rechercher

- Signes d'atteinte neurologique : céphalées, troubles de la conscience, déficit neurologique (suspecter une hémorragie intracrânienne).

- Signes de choc hémorragique : hypotension, tachycardie, marbrures, anurie.
- Hémorragies viscérales massives : méléna, hématurie massive, hémoptysie.

IV.3 Les purpuras

Le purpura est une extravasation du sang hors des capillaires cutanés. Il peut être isolé ou associé à des hémorragies des muqueuses et viscères, réalisant alors le purpura hémorragique. Il s'agit le plus souvent d'affections acquises dues à une anomalie de l'hémostase primaire. Les hémorragies sont spontanées et superficielles.

Signes cutanés

Le purpura est une hémorragie cutanée ne s'effaçant pas à la vitro-pression ; il doit être différencié de l'érythème et des télangiectasies qui s'effacent à la vitro-pression.

Il peut se présenter sous trois aspects principaux :

- Pétéchies : macules rouge vif, punctiformes, de diamètre inférieur à 1 cm, prédominant au niveau des membres inférieurs et des zones de contention.
- Vibices : hémorragies cutanées linéaires, en stries, siégeant surtout au niveau des plis de flexion.
- Ecchymoses (bleus) : hémorragies cutanées siégeant au niveau de l'hypoderme, de coloration bleu foncé, évoluant par dégradation de la bilirubine (violet, vert, jaune).

Des lésions associées peuvent être présentes : macules, papules, vésicules et bulles.

Hémorragies muqueuses

- Bulles sanglantes au niveau de la muqueuse buccale
- Epistaxis (saignement nasal)
- Gingivorragies (saignement des gencives)
- Hémorragies génitales : le plus souvent ménorragies abondantes

Hémorragies viscérales

Plus rares mais graves :

- Hémorragies digestives : méléna, hématurie
- Hémorragies rétinienne : très graves car risquant d'entraîner une cécité définitive
- Hémorragies méningées : très graves, risquant d'entraîner la mort

IV.4 Les coagulopathies

Les coagulopathies réalisent des hémorragies de type différent des purpuras : hématomes sous-cutanés, hémorragies muqueuses surtout à type d'épistaxis, et hémorragies profondes (musculaires et articulaires). Ces hémorragies sont le plus souvent provoquées par un traumatisme.

Caractéristiques cliniques

Elles sont le plus souvent constitutionnelles ; le type le plus caractéristique est l'hémophilie. Elles peuvent être acquises : traitement aux anticoagulants, insuffisance hépatique, carence en vitamine K.

Circonstances de survenue

- Traumatismes accidentels : les blessures profondes entraînent des hémorragies persistantes.
- Extractions dentaires : chez le sujet normal, le saignement s'arrête au bout de 30 minutes. Au cours d'une coagulopathie, le saignement initial est identique à celui du sujet normal, mais après un arrêt initial, le saignement reprend et persiste pendant plusieurs jours. Ce phénomène est pathognomonique d'un trouble de la coagulation.
- Interventions chirurgicales : peuvent faire découvrir une coagulopathie, notamment l'hémophilie chez l'enfant lors d'amygdalectomie ou de circoncision. Ces interventions peuvent s'accompagner d'hémorragies prolongées et abondantes pouvant mettre en danger la vie du malade.

Examen clinique selon l'âge

- Nourrisson : hématomes cutanés au niveau du front et des membres, suite à des traumatismes minimes du quotidien.
- Enfant marchant : hémarthroses (hémorragies intra-articulaires), très caractéristiques des coagulopathies, siégeant au niveau des grosses articulations (genoux, chevilles, coudes, hanches).
- Hématomes profonds : siègent dans les espaces cellulo-aponévrotiques après un traumatisme ou une injection intramusculaire. Volumineux et douloureux, ils peuvent entraîner des compressions nerveuses au niveau des membres ou simuler une urgence chirurgicale (exemple : hématome du psoas pouvant mimer une appendicite aiguë).

- Hématuries : fréquentes dans les coagulopathies constitutionnelles ; elles constituent également un premier signe de surdosage aux anticoagulants.

V. Principaux syndromes hémorragiques

1 . Causes locales

Le mécanisme hémorragique le plus fréquent est d'origine locale par brèche vasculaire. Il réalise une hémorragie localisée d'abondance variable, en rapport avec une lésion vasculaire d'un viscère.

Exemples : hémorragie digestive par ulcère gastrique ou duodénal, rupture de varices oesophagiennes au cours de l'hypertension portale, hémoptysie par brèche d'un vaisseau bronchique.

2. Purpuras vasculaires et thrombopéniques

Les purpuras traduisent une anomalie de l'hémostase primaire (paroi vasculaire ou plaquettes).

Purpura vasculaire

Le purpura rhumatoïde (ou purpura de Henoch-Schönlein) atteint l'enfant et le sujet jeune. Il associe :

- Un purpura pétéchial et ecchymotique, souvent en poussées, prédominant aux membres inférieurs et aux fesses.
- D'autres lésions cutanées de nature inflammatoire : érythème, macules et papules.
- Des arthralgies et arthrites (genoux, chevilles).
- Des signes abdominaux : crises douloureuses avec parfois hémorragies digestives à type de méléna.

Il s'agit d'un purpura aigu allergique (vasculite des petits vaisseaux par dépôts d'IgA). Biologiquement, le signe du lacet peut être positif, mais le temps de saignement et le taux des plaquettes sont normaux.

Le purpura sénile se voit chez le sujet âgé. Il réalise soit un purpura pétéchial, soit des hémorragies cutanées en plaques siégeant au dos des mains et la face dorsale de l'avant-bras, lié à la fragilité vasculaire du vieillard.

Purpura thrombopénique

Il associe un purpura pétéchial et ecchymotique à des hémorragies muqueuses. Biologiquement, le signe du lacet est souvent positif, le temps de saignement est allongé et le chiffre des plaquettes est effondré (inférieur ou égal à $50\,000/\text{mm}^3$).

Les principales causes de thrombopénie sont : la thrombopénie immunitaire (PTI), les aplasies médullaires, les métastases osseuses, les infections virales sévères, et les médicaments.

3 . Coagulopathies constitutionnelles et acquises

Coagulopathies constitutionnelles

L'hémophilie est le prototype des coagulopathies constitutionnelles. Elle atteint principalement les garçons (transmission liée à l'X).

- Hémophilie A : déficit en Facteur VIII (85% des cas).
- Hémophilie B (maladie de Christmas) : déficit en Facteur IX (15% des cas).

Cliniquement, les manifestations sont précoces : hémorragies prolongées lors de la circoncision, hémarthroses à répétition au niveau des grosses articulations (genoux, chevilles, coudes), hématomes profonds, hématuries.

Biologiquement, les tests d'hémostase primaire sont normaux. Parmi les tests explorant la coagulation, seul le TCA est allongé ; le TP est normal. Le dosage du facteur déficient confirme le diagnostic.

Coagulopathies acquises

Les coagulopathies acquises sont principalement iatrogènes ou liées à une pathologie sous-jacente :

- Surdosage aux anticoagulants : héparine (antithrombine) ou antivitamines K (AVK : inhibent la synthèse hépatique des facteurs du complexe prothrombinique : II, VII, IX, X).
- Insuffisance hépatique : le foie synthétisant la majorité des facteurs de coagulation et le fibrinogène, une hépatocellulaire sévère entraîne une coagulopathie.
- Carence en vitamine K : essentielle à la synthèse des facteurs II, VII, IX, X et des protéines C et S.
- Accidents thrombotiques : syndrome des caillots emboliques de progressive (disseminated intravascular coagulation), CIVD.

La surveillance biologique stricte et régulière est impérative au cours des traitements anticoagulants. Pour les AVK, le suivi se fait par l'INR (cible généralement entre 2 et 3 selon l'indication). Pour l'héparine, on surveille le TCA ou l'activité anti-Xa.

4. CIVD et fibrinolyse

Coagulation Intravasculaire Disséminée (CIVD)

La CIVD est une activation diffuse et incontrôlée de la coagulation intravasculaire, entraînant la formation de caillots dans la microcirculation et une consommation des facteurs de coagulation et des plaquettes. Cette consommation expose au risque hémorragique majeur.

Étiologies principales : infections sévères (sepsis), choc, traumatisme majeur, certaines hémopathies malignes (promyélocytaire aiguë), complications obstétricales (rétention mortelle, amniocentèse, pré-éclampsie sévère), morsures de serpents.

Diagnostic biologique : allongement du TP et du TCA, thrombopénie, hypofibrinogénémie, élévation des D-dimères et des produits de dégradation de la fibrine.

Fibrinolyse primaire

Plus rare, elle correspond à une activation pathologique de la fibrinogénolyse sans CIVD sous-jacente. Elle se traduit par un saignement hémorragique avec hypofibrinogénémie et élévation des D-dimères, mais sans thrombopénie ni consommation des facteurs de coagulation.

VI. Conduite diagnostique

Face à un syndrome hémorragique, la démarche diagnostique doit être structurée et rapide, en particulier en cas de gravité.

Étapes diagnostiques

5. **Confirmation de l'hémorragie** : caractériser le type de saignement (cutanéomuqueux, profond, viscéral) et évaluer son abondance.
6. **Recherche d'une cause locale** : exclure une brèche vasculaire ou un traumatisme local avant d'évoquer une anomalie de l'hémostase.

- 7. **Orientation par la sémiologie** :les hémorragies superficielles et spontanées orientent vers une anomalie de l'hémostase primaire ; les hémorragies profondes et retardées orientent vers une anomalie de la coagulation.
- 8. **Bilan biologique initial** :numération plaquettaire, TP/INR, TCA, fibrinogène, D-dimères.
- 9. **Bilan étiologique** :selon les résultats, dosage des facteurs de coagulation, recherche d'anticorps antiplaquettaires, bilan hépatique, etc.

Tableau récapitulatif différentiel

Caractéristique	Hémostase primaire	Coagulation	CIVD
Type de saignement	Superficiel	Profond / retardé	Diffuse / sévère
Lésions cutanées	Pétéchies, purpura	Hématomes	Pétéchies + hématomes
Hémorragies	Muqueuses	Articulaires, musculaires	Tous types
Tests biologiques	TS allongé	TCA ou TP allongé	TP+TCA+TT allongés
Numération plaquettes	Bas	Normal	Bas
Fibrinogène	Normal	Normal	Bas
D-dimères	Normal	Normal	Elevés

Prise en charge urgente

En cas de syndrome hémorragique grave :

- Remplissage vasculaire et transfusion de concentrés érythrocytaires si choc hémorragique.
- Correction urgente du trouble de la coagulation : concentrés de plaquettes si thrombopénie, plasma frais congelé si déficit des facteurs de coagulation, vitamine K si trouble lié aux AVK.
- En cas d'hémophilie : administration de facteur VIII ou IX concentré.
- En cas de CIVD : traitement de la cause, apport de plasma et fibrinogène, anticoagulation par héparine en cas de thrombose dominante.

Dr BOUACHIBA ZINEB

MAITRE ASSISTANTE EHDM

